

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	新生兒後天性免疫不全症候群 Neonatal AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)				
編號	A31000-Q03-W-N16	制定者	IR 黃淑媛	公布日期	100 年 08 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 01 月 06 日
版本/總頁數	第 2.7 版/10 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 01 月 06 日

一、目的

讓護理人員瞭解後天性免疫不全症候群新生兒之篩檢作業、照護注意事項、治療用藥之標準與環境清潔消毒方式。

二、範圍

新生兒中重度病房、新生兒加護病房。

三、說明

(一) 定義

愛滋病就是後天免疫缺乏症候群(Acquired Immunodeficiency Syndrome, AIDS)的簡稱，指因為病患身體抵抗力低，導致得到各種疾病的症狀。愛滋病毒為人類免疫缺乏病毒(Human Immunodeficiency Virus, HIV)的簡稱，是一種破壞免疫系統的病毒。

(二) 症狀

因母子間垂直感染愛滋病毒的小兒，大約 20%在出生後數個月內就有嚴重的臨床症狀，且病情進展甚快，患者快速死亡。其餘患童病程進展較慢，每年約有 10%發病，平均發病年齡在 3~5 歲之間，平均可存活至 9~10 歲。愛滋病患童常見的臨床症狀和成人不同。嬰兒期即發病的患童，常併發肺囊蟲肺炎，死亡率很高，平均存活 1~4 個月。其他常見的症狀，包括：消耗症(Wasting syndrome)及腦病變。相反地，較晚發病的患童，常見的症狀，包括：反覆性細菌感染、全身淋巴腺腫大、肝腫大、淋巴性間質性肺炎(Lymphocytic interstitial pneumonitis)、耳下腺腫大等等。此外，仔細評估中樞神經功能對小兒愛滋病患相當重要，因為 90%以上

主題名稱	新生兒後天性免疫不全症候群	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N16	版本	第 2.7 版	頁碼/總頁數	2/10

愛滋病童會出現或多或少的神經學異常，發病的孩子當中高達 60%表現出進行性腦病變。而成人愛滋病患常見的卡波西氏肉瘤、淋巴瘤及中樞神經的伺機性感染則較少見。至於孩童及成人愛滋病患都很常見的表現，包括：非中樞神經的伺機性感染，如肺囊蟲肺炎、神經學異常、慢性或反覆性濕疹、皮疹(Exanthema)、腹瀉、發燒、瀰漫性腺體病變、心肌病變。

(三) 常見檢查

1. HIVp24 抗原檢測法。
2. HIV DNA PCR。
3. HIV RNA PCR。
4. HIV 病毒培養。

(四) 藥物治療

1. 感染愛滋病毒孕婦所生之嬰幼兒，自嬰兒出生後 6-12 小時開始，需每 12 小時口服 Zidovudine(ZDV) 4mg/kg/dose，依醫囑讓新生兒口服 Zidovudine (ZDV 糖漿)，每 12 小時一次，每次劑量 4mg/kg/dose，持續服用六週。
2. 不足 35 週出生的嬰兒 Zidovudine 劑量為每 12 小時靜脈注射 1.5mg/kg，或口服 2.0mg/kg，每日 2 次；30 週以上出生者，出生後滿 2 週大時改為每次劑量 3mg/kg/BW，每 12 小時口服或注射一次，不足 30 週出生者，則到產後滿四週大時才改為每 8 小時注射或口服一次。衛教返家後照護：不要哺餵母乳，需定期服藥：疑似愛滋寶寶應在出生後給予口服 ZDV 六週，並按時追蹤，證實感染 HIV 後，應立即停用預防性的 ZDV，轉而使用 HAART。疫苗接種與一般嬰兒相同，但減毒小兒麻痺口服疫苗不能使用，改施打沙克疫苗（不活性小兒麻痺疫苗）。
3. Zidovudine 應在出生後盡早給予，最好是在出生後 6-12 小時內，無法忍受口服方式的足月生產嬰兒可使用靜脈注射 Zidovudine，劑量為每 6 小時 1.5mg/Kg；不足 35 週出生的嬰兒，Zidovudine，劑量為每 12 小時靜脈注射一劑 1.5mg/Kg，或口服一劑 2.0mg/kg，每日二次；若懷孕 30 週以上出生，則到生產後滿兩週

主題名稱	新生兒後天性免疫不全症候群	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N16	版本	第 2.7 版	頁碼/總頁數	3/10

大改為每 8 小時注射或口服一次；若懷孕不足 30 週出生者，則到生產後滿四週大時才改為 8 小時一次。

4. 新生兒為期 6 週之預防性治療，有些臨床醫師會在 Zidovudine 以外加上其他抗愛滋病毒藥物，請先諮詢兒科醫師。

(五) 護理問題

易感染／免疫功能不成熟及侵入性導管

(六) 護理措施

1. 在執行每個病人照護活動的前後洗手。
2. 於執行傷口護理時，維持無菌技術。
3. 注意傷口的特徵。
4. 監測全身性及局部性的感染徵象與症狀。
5. 觀察有無需要移除導管之徵象，盡早拔除避免增加感染的機會。

(七) 衛教指導

1. 不要哺餵母乳。
2. 需定期服藥：疑似愛滋寶寶應在出生後給予口服 ZDV 六週，並按時追蹤，證實感染 HIV 後，應立即停用預防性的 ZVD，轉而使用 HAART。
3. 疫苗接種與一般嬰兒相同，但減毒小兒麻痺口服疫苗不能使用，改施打沙克疫苗（不活性小兒麻痺疫苗）。
4. 建議接種所有常規疫苗（除水痘外，因有可能產生全身性疾病風險；活性疫苗不應使用，若需給予需照護感染科醫師）。
5. 注意伺機感染和預防。

(八) 疑似愛滋寶寶篩檢作業：

依據行政院衛生署疾病管制局「愛滋母子垂直感染防治政策」中疑似愛滋寶寶篩檢作業流程（流程一），提供護理人員疑似愛滋寶寶之篩檢流程依據。

(九) 愛滋寶寶照護注意事項：

1. 病人辨識：依據新生兒加護病房病人手腳圈及病歷資料由兩位護理人員雙

主題名稱	新生兒後天性免疫不全症候群	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N16	版本	第 2.7 版	頁碼/總頁數	4/10

重核對並簽章，需注意不可於寶寶床頭卡做任何特殊註記。

2. 由於 HIV 病毒可存在於母乳中，已被證實 HIV 可藉哺餵母乳傳播給寶寶，因此要衛教感染愛滋病毒的媽媽不要哺餵母乳。
3. 疑似愛滋之寶寶，在尚未確診感染 HIV 之前，平常即採接觸性隔離防護措施的照護（預防粘膜或傷口接觸血液：戴手套、口罩、護目裝備），接觸胎脂、羊水及血液需配戴護目鏡、穿隔離衣及手套，新生兒護理時改量背溫或腋溫，勿量肛溫。
4. 餵食採用配方奶，依醫囑給予口服用藥。
5. 疑似愛滋寶寶，出生後第一次沐浴宜用稀釋 0.1%(1:1000)的漂白水，之後用一般沐浴清潔劑，平時使用中性肥皂洗澡及定期修剪指甲以保持體表完整並預防感染。
6. 美國疾病控制中心於 1998 年發表醫療工作人員暴露於 HIV 感染源之後的處理要點指出，應立即用肥皂及清水沖洗傷口，透過完整的通報系統，謹慎評估感染 HIV 的機率，臨床護理人員應嚴格遵循全面血液和體液防護措施及基本感染管制措施。
7. 黃膽追蹤使用抽血送檢，不扎腳跟血。

(9) 環境場所之清潔消毒工作

1. 依據本院院內感染管制政策指導書(212070-AAA-P-017)醫院環境衛生管理及(212070-ACA-P-005)人類免疫缺乏病毒傳染之感染管制政策執行環境清潔，有病人體液或引流液污染，才用 0.5%漂白水（次氯酸鈉）。
2. 病室常規清洗可用新鮮泡製之 0.05%漂白水（次氯酸鈉）。只要不含血液成分的分泌物，可用一般的衛生紙處理，依一般方式丟棄，環境清潔照一般的方式即可，並不需要戴手套處理。
3. 沾染血液之床單、被單、枕套應以感染性塑膠袋封紮送洗，牆壁、地板、桌椅沾染血液、體液等，可以 0.5%漂白水（次氯酸鈉）擦洗。

主題名稱	新生兒後天性免疫不全症候群	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N16	版本	第 2.7 版	頁碼/總頁數	5/10

4. 疾管局指出：若是含血液的分泌物噴濺到環境物體上，則須先戴手套（可用重複使用的手套）去除較大範圍的有機物，小的有機物可不戴手套直接以衛生紙清除，最後以家用含氯成分的漂白水，稀釋至 1：10 擦拭物體表面，手套脫除後仍應確實洗手。1.若地板等受愛滋感染者或病人血液污染時，應使用消毒水進行消毒。消毒劑包括：0.3%雙氧水、50%酒精、0.5%Lysol、家用漂白劑等。其中最有效且便宜者為家用含氯成分的漂白水，稀釋至 1：10（用於表面粗糙時）或 1：100（用於平面且容易清洗時）；惟稀釋液應於 24 小時內使用。
5. 受愛滋感染者或病人血液污染之廢棄物，建議以高濃度漂白水(0.5%)浸泡消毒 30 分鐘後再丟棄。
6. 家庭用漂白水次氯酸鈉(NaOCl)的成份通常在 3%到 6%。Suarez(2002)建議 100-200 ppm（一般使用 200 ppm）；但如為消毒排泄物或嘔吐物，次氯酸鈉的濃度則要提高到 3-5%。

（十）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

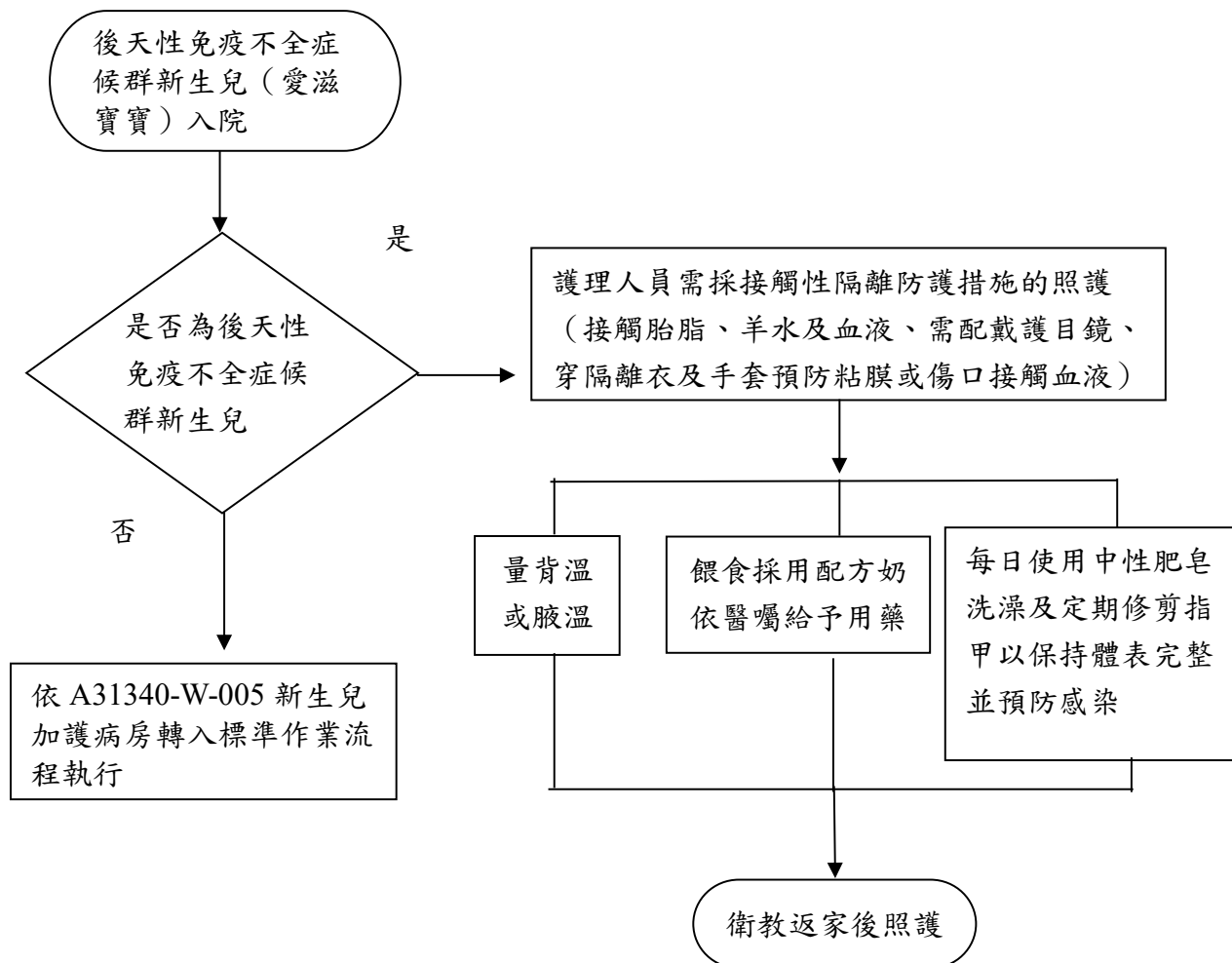
四、使用表單

（略）

主題名稱	新生兒後天性免疫不全症候群	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q03-W-N16	版本	第 2.7 版	頁碼/總頁數	6/10

五、流程圖

(一) 疑似愛滋寶寶住院照護作業流程：本院 NICU、IR 作業流程如下：



六、參考資料

- (一) 衛生福利部疾病管制局(2022)．人類免疫缺乏病毒感染的臨床表徵、診斷與治療指引（五版），台北：衛生福利部疾病管制局。
- (二) 陳月枝(2021)．新生兒 AIDS 藥物治療．於陳月枝總校閱，實用兒科護理（九版，122-126 頁）．台北：華杏。
- (三) 呂俊毅、劉惠青、黃立民(2018)．兒童及青少年愛滋病毒感染之臨床表徵、診斷與治療指引（八章，2 頁）。

主題名稱	新生兒後天性免疫不全症候群	制定單位	護理部
編號	A31000-Q03-W-N16	版本	第 2.7 版
		頁碼/總頁數	7/10

(四) 葉乙臻、潘政燕、劉秀雲(2020)，照顧愛滋感染合併淋巴瘤末期患者之護理經驗，*安寧療護雜誌*,24(3), 267-276。

(五) Button, E., Chan, R. J., Chambers, S., Butler, J., & Yates, P. A systematic review of prognostic factors at the end of life for people with a hematological malignancy. *BMC Cancer* 2017; 17(1): 213-28.

七、 附件

(一) 行政院衛生署疾病管制局(2010)·疑似愛滋寶寶篩檢作業流程

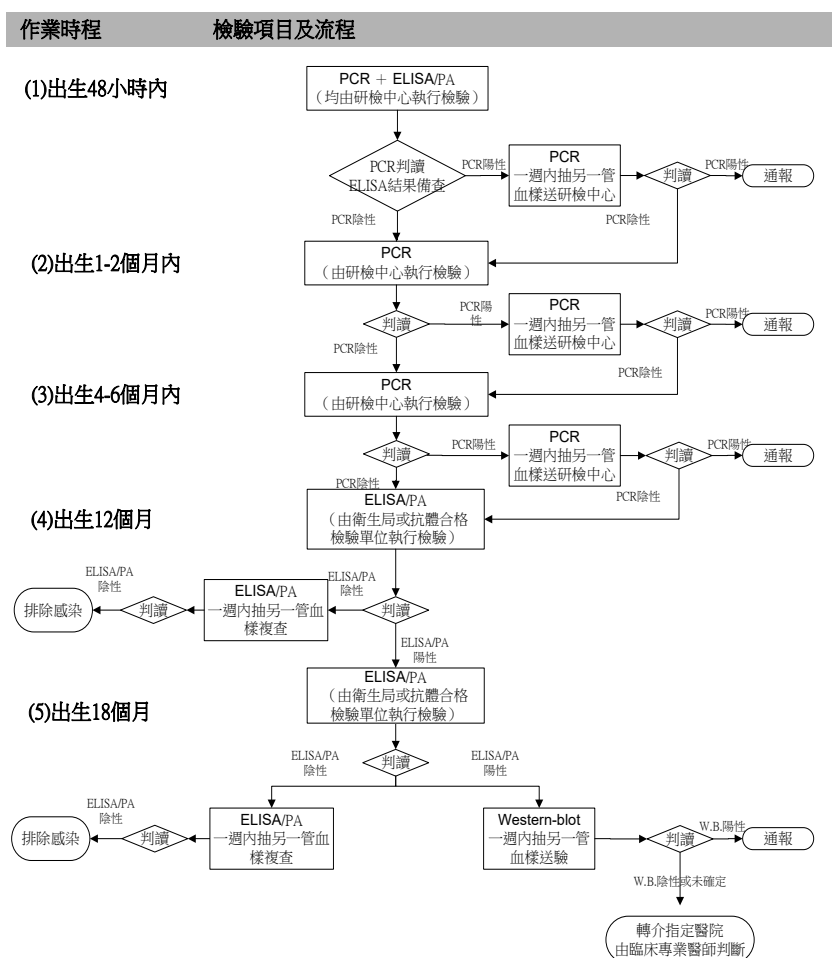
疑似愛滋寶寶篩檢作業流程

附錄一

※注意事項：

- 1.請以EDTA或非heparin抗凝血試管（紫頭管）採檢全血3-5ml、4℃低溫、24小時內送驗。
- 2.疑似愛滋寶寶，出生6-12小時內應給予預防性投藥，至少治療6週。
- 3.確診陽性個案應即停止預防性投藥，轉介愛滋病指定醫院並施予完整抗病毒治療。

以上治療請參照「愛滋病檢驗及治療指引」。



主題名稱	新生兒後天性免疫不全症候群	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N16	版本	第 2.7 版	頁碼/總頁數	8/10

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
100.08.31	1.0	新制定。	100 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
101.08.31	1.1	醫護部改護理部。	101 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
102.02.08	2.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
103.06.30	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.08.31	2.1	1.第三項部份內容刪修。 2.增修第六項參考文獻資料。	104 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
105.08.31	2.2	將參考文獻出處呈現於內文中。	105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
106.08.31	2.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	2.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.06.06	2.3	第三項第十目本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 06 月 06 日照護標準組會議通過； 108 年 06 月 12 日護理長會議通過； 108 年 06 月 18 日督導會議通過公布。
109.08.06	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.10.07	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.11.08	2.4	1. 第三項第一、二目內容刪修。 2. 修正第三項第五目護理問題。 3. 增修第六項參考文獻資料。 4. 內文參考文獻引用刪除。	111 年 10 月 06 日照護標準組會議通過； 111 年 10 月 12 日護理長會議通過； 111 年 11 月 08 日督導會議通過公布。

主題名稱	新生兒後天性免疫不全症候群	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q03-W-N16	版本	第 2.7 版	頁碼/總頁數	10/10

修正日期	版本	修正說明	備註